

QCM - Motilité oculaire et strabisme - Corrigé

40 questions couvrant les cours : Introduction au strabisme, Les strabismes concomitants, Physiopathologie et classification des strabismes, et Malvoyance chez l'enfant.

Question 1 - Quelle est la définition de l'axe visuel ?

✓ Réponse : B. La ligne joignant la fovéa et le point de fixation, en passant par le point nodal de l'œil

L'axe visuel joint la fovéa et le point de fixation, en passant par le point nodal de l'œil. L'axe anatomique, lui, joint le pôle postérieur et le centre de la cornée.

Question 2 - L'angle kappa est défini comme :

✓ Réponse : B. L'angle entre l'axe visuel et l'axe anatomique

L'angle kappa est l'angle sous-tendu par l'axe visuel et l'axe anatomique (environ 5°).

Question 3 - Lors de la méthode aux reflets (test de Hirschberg), l'orthophorie est définie par :

✓ Réponse : B. Des reflets cornéens symétriques par rapport à l'arête nasale

En orthophorie, les reflets sont symétriques par rapport à l'arête nasale, ce qui traduit un alignement parfait des deux yeux sans effort.

Question 4 - L'hétérophorie se distingue de l'hétérotropie en ce que :

✓ Réponse : B. L'hétérophorie est une tendance à la déviation uniquement lorsque la fusion est bloquée

L'hétérophorie est un strabisme latent : la déviation n'apparaît que quand la fusion est bloquée (par exemple sous écran). L'hétérotropie est une déviation manifeste.

Question 5 - Les ductions sont des mouvements oculaires :

✓ Réponse : C. Monoculaires d'un seul œil (adduction, abduction, élévation, abaissement)

Les ductions sont des mouvements oculaires monoculaires : adduction, abduction, élévation, abaissement.

Question 6 - Les vergences sont des mouvements oculaires binoculaires :

✓ Réponse : B. Simultanés et de sens opposés

Les vergences sont des mouvements binoculaires simultanés et de sens opposés (convergence ou divergence), contrairement aux versions qui sont conjugués dans la même direction.

Question 7 - La loi de Sherrington d'innervation réciproque stipule que :

✓ Réponse : B. L'augmentation de l'influx d'un muscle est accompagnée d'une diminution de l'influx de son antagoniste

La loi de Sherrington stipule que l'augmentation de l'influx nerveux d'un muscle extraoculaire est accompagnée d'une diminution de l'influx nerveux de son muscle antagoniste (inhibition réciproque).

Question 8 - La loi de Hering d'innervation égale concerne :

✓ **Réponse : B. L'innervation symétrique des muscles controlatéraux synergiques lors des mouvements conjugués**

Lors des mouvements oculaires conjugués, la loi de Hering prévoit qu'une quantité égale et simultanée d'influx nerveux est transmise aux muscles controlatéraux synergiques (yoke muscles).

Question 9 - Lors de l'apparition d'un strabisme, la confusion est due au fait que :

✓ **Réponse : A. Les deux maculas reçoivent les images de deux points différents, extériorisés au même endroit**

La confusion survient car les deux maculas reçoivent les images de deux points différents ; le cortex visuel les extériorise au même lieu de l'espace, ce qui crée une confusion. La neutralisation maculaire est le mécanisme de défense mis en place.

Question 10 - La correspondance rétinienne anormale (CRA) est :

✓ **Réponse : B. Un phénomène positif d'adaptation : modification des références spatiales de la rétine de l'œil dévié pour éviter la diplopie**

La CRA est un phénomène positif d'adaptation sensorielle : les références spatiales de la rétine de l'œil dévié se modifient pour éviter la diplopie. La suppression est le phénomène négatif correspondant.

Question 11 - Un strabisme concomitant se caractérise par :

✓ **Réponse : B. Une déviation constante dans toutes les directions du regard avec une motilité oculaire conservée**

Dans les strabismes concomitants, l'angle de déviation reste constant dans toutes les directions du regard et la motilité oculaire est conservée. Cela traduit principalement un déséquilibre du contrôle binoculaire.

Question 12 - Chez l'enfant strabique, pourquoi la diplopie est-elle rarement présente ?

✓ **Réponse : B. Car le cerveau met en place des mécanismes d'adaptation comme la suppression de l'image de l'œil dévié**

Chez l'enfant, le strabisme concomitant entraîne rarement une diplopie car le cerveau met en place rapidement des mécanismes d'adaptation, principalement la suppression de l'image de l'œil dévié.

Question 13 - Parmi les classifications des strabismes concomitants, selon la direction de la déviation on distingue :

✓ **Réponse : B. Les ésotropies (déviation vers l'intérieur) et les exotropies (déviation vers l'extérieur)**

Les ésotropies sont caractérisées par une déviation vers l'intérieur (convergence) et les exotropies par une déviation vers l'extérieur (divergence).

Question 14 - Lors du cover test alterné, quel mouvement indique la présence d'une tropie (strabisme manifeste) ?

✓ **Réponse : A. Un mouvement de refixation de l'œil découvert lors de la levée de l'occlusion de l'autre œil**

Lorsque l'on couvre un œil et que l'œil controlatéral effectue un mouvement de refixation, cela indique la présence d'un strabisme manifeste (tropie). Le test alterné permet de mesurer l'angle total de déviation.

Question 15 - L'ésotropie accommodative est principalement liée à :

✓ **Réponse : B. Une hypermétropie non corrigée entraînant une accommodation excessive et une convergence excessive**

L'ésotropie accommodative est liée à une hypermétropie non corrigée qui entraîne une accommodation excessive, elle-même responsable d'une convergence excessive. Elle apparaît généralement entre 2 et 4 ans et disparaît souvent avec la correction optique.

Question 16 - L'ésotropie infantile se caractérise notamment par :

✓ **Réponse : B. Son apparition avant 6 mois, un angle important, souvent associée à un nystagmus latent**

L'ésotropie infantile apparaît généralement avant 6 mois. Elle se caractérise par un angle important et constant. On observe fréquemment des signes associés tels qu'un nystagmus latent ou une hyperaction des obliques inférieurs.

Question 17 - L'exotropie intermittente se manifeste préférentiellement lors de :

✓ **Réponse : B. La fatigue, l'inattention, la forte luminosité et la fixation au loin**

L'exotropie intermittente se manifeste principalement lors de la fatigue, de l'inattention, de la forte luminosité ou lors de la fixation au loin. Les patients peuvent fermer un œil en pleine lumière.

Question 18 - Le microstrabisme se distingue des autres strabismes par :

✓ **Réponse : B. Un angle de déviation faible (< 10 DP), difficile à voir à l'inspection, souvent associé à une CRA**

Le microstrabisme correspond à une déviation de faible amplitude (généralement < 10 DP), souvent associée à une amblyopie modérée et à une CRA. Il nécessite des tests spécifiques pour être détecté (test de Lang, test de fixation excentrée).

Question 19 - Le traitement de l'amblyopie repose principalement sur :

✓ **Réponse : B. L'occlusion de l'œil dominant pour stimuler l'œil amblyope**

Le traitement de l'amblyopie repose principalement sur l'occlusion de l'œil dominant afin de

stimuler l'œil amblyope. Des alternatives comme la pénalisation optique ou pharmacologique peuvent aussi être utilisées.

Question 20 - La chirurgie des strabismes concomitants est indiquée lorsque :

✓ **Réponse : B. La déviation persiste malgré une prise en charge bien conduite (correction optique, traitement de l'amblyopie)**

Le traitement chirurgical est indiqué lorsque la déviation persiste malgré une prise en charge bien conduite (correction optique et traitement de l'amblyopie). Il consiste à modifier l'action des muscles oculomoteurs par recul ou résection.

Question 21 - Selon l'OMS, une déficience visuelle est définie par une acuité visuelle inférieure à :

✓ **Réponse : B. 3/10 avec correction optique**

Selon l'OMS, une acuité visuelle inférieure à 3/10 avec correction optique est considérée comme une déficience visuelle.

Question 22 - Le champ visuel normal commun aux deux yeux s'étend sur :

✓ **Réponse : C. 180° de large et 130° verticalement**

Normalement, le champ commun aux deux yeux s'étend sur 180° de large et 130° verticalement.

Question 23 - Le glaucome congénital se caractérise par :

✓ **Réponse : B. Une anomalie de développement de l'angle irido-cornéen empêchant l'évacuation de l'humeur aqueuse**

Le glaucome congénital est dû à une anomalie de développement de l'angle irido-cornéen qui empêche l'évacuation de l'humeur aqueuse. C'est la 1ère cause de cécité infantile en Tunisie.

Question 24 - Quel est le signe de découverte le plus fréquent de la cataracte congénitale ?

✓ **Réponse : C. La leucocorie (reflet blanc de la pupille)**

La leucocorie (pupille blanche) est le signe de découverte le plus fréquent de la cataracte congénitale. Elle est également le signe d'appel du rétinoblastome.

Question 25 - Le rétinoblastome est :

✓ **Réponse : B. La tumeur maligne primitive de la rétine la plus fréquente chez l'enfant, dont le signe d'appel est la leucocorie**

Le rétinoblastome est la tumeur maligne primitive de la rétine la plus fréquente chez l'enfant. Le signe d'appel le plus fréquent est la leucocorie (pupille jaune). Le diagnostic doit être fait précocement pour améliorer le pronostic vital et fonctionnel.

Question 26 - La rétinopathie du prématuré est liée à :

✓ **Réponse : B. Un trouble prolifératif des vaisseaux sanguins de la rétine en développement chez les nourrissons prématurés**

La rétinopathie du prématuré est un trouble prolifératif touchant les vaisseaux sanguins de la rétine en développement des nourrissons prématurés. Le processus vasculaire de la rétine est normalement complété vers la 40e semaine de gestation.

Question 27 - La maladie de Stargardt est :

✓ **Réponse : A. La dystrophie maculaire juvénile la plus fréquente, de transmission autosomique récessive**

La maladie de Stargardt est la dystrophie maculaire juvénile la plus fréquente (prévalence 1/10 000). Elle est caractérisée par une accumulation anormale de lipofuscine dans l'épithélium pigmentaire rétinien et est de transmission autosomique récessive.

Question 28 - L'albinisme est caractérisé par :

✓ **Réponse : B. Une absence partielle ou totale de mélanine, entraînant une dépigmentation et une mauvaise acuité visuelle**

L'albinisme est une maladie génétique due à une anomalie héréditaire de la mélanine, caractérisée par une absence partielle ou totale de mélanine. Il en résulte une dépigmentation et une mauvaise acuité visuelle, ainsi qu'une susceptibilité aux affections cutanées.

Question 29 - Le test de Hirschberg (reflets cornéens) chez l'enfant permet de :

✓ **Réponse : C. Dépister un strabisme en vérifiant la centration des reflets cornéens lors d'une illumination frontale**

Le test de Hirschberg consiste à présenter une source lumineuse face au visage de l'enfant. Les reflets cornéens projetés doivent être centrés. En cas de strabisme, un des reflets ne sera pas centré.

Question 30 - Parmi les aides visuelles suivantes, laquelle permet les grossissements les plus importants (jusqu'à 50 fois) ?

✓ **Réponse : D. Les agrandisseurs électroniques (associant caméra et écran)**

Les agrandisseurs électroniques, associant caméra et écran, permettent des grossissements jusqu'à 50 fois, ce qui est supérieur aux autres aides optiques. Certains peuvent également se relier à un ordinateur.

Question 31 - La triade proximale regroupe trois phénomènes neurologiquement couplés, lesquels ?

✓ **Réponse : A. Accommodation, convergence et myosis**

La triade proximale regroupe accommodation, convergence et myosis. Ces trois phénomènes sont neurologiquement couplés. C'est le lien entre accommodation et convergence qui explique les strabismes accommodatifs.

Question 32 - Quelle est la différence entre une phorie et une tropie ?

✓ **Réponse : B. La phorie est compensée par la fusion (latente) ; la tropie est visible spontanément (manifeste)**

La phorie est une déviation latente compensée par la fusion ; elle ne se manifeste que quand la fusion est bloquée. La tropie est une déviation manifeste visible spontanément.

Question 33 - Dans un strabisme non concomitant, la déviation :

✓ **Réponse : B. Varie selon la direction du regard et traduit une atteinte musculaire ou neurologique**

Dans un strabisme non concomitant, la déviation varie selon la direction du regard, ce qui traduit une atteinte musculaire ou neurologique avec une limitation de la motricité oculaire (angle variable + limitation motrice).

Question 34 - Le torticolis compensateur dans le strabisme paralytique permet au patient de :

✓ **Réponse : B. Adopter une position de tête pour éviter la diplopie**

Dans les strabismes non concomitants paralytiques, le patient adopte une position anormale de la tête (torticolis compensateur) pour éviter la diplopie. C'est un signe très important pour l'orthoptiste.

Question 35 - Le strabisme accommodatif pur se caractérise par :

✓ **Réponse : B. Une déviation totalement corrigée par la correction optique adaptée**

Le strabisme accommodatif pur est totalement corrigé par la correction optique (lunettes). C'est un élément clé pour le diagnostic. Le strabisme partiellement accommodatif, lui, persiste partiellement malgré la correction.

Question 36 - La paralysie du nerf VI (nerf abducens) entraîne :

✓ **Réponse : B. Un déficit d'abduction avec ésoptropie, car le droit latéral est paralysé**

Le nerf VI innerve le muscle droit latéral. Sa paralysie entraîne un déficit d'abduction → ésoptropie. C'est la paralysie des nerfs oculomoteurs la plus fréquente.

Question 37 - Un strabisme intermittent se caractérise par :

✓ **Réponse : B. Une déviation non constante avec alternance de phases alignées et de phases de déviation, car le système de fusion fonctionne encore partiellement**

Le strabisme intermittent est caractérisé par une déviation non constante : il y a alternance entre des phases alignées et des phases de déviation. Cela signifie que le système de fusion fonctionne encore partiellement mais est instable ou dépassé dans certaines conditions.

Question 38 - Le strabisme sensoriel est secondaire à :

✓ **Réponse : B. Une baisse de vision unilatérale, quelle qu'en soit la cause, empêchant le maintien de l'alignement oculaire**

Le strabisme sensoriel est secondaire à une baisse de vision unilatérale : la perte de qualité de l'image rétinienne empêche le maintien de l'alignement oculaire. Il peut s'agir d'une ésoptropie ou d'une exotropie selon les cas.

Question 39 - Dans la physiopathologie générale du strabisme, le déséquilibre repose sur l'interaction de trois systèmes, lesquels ?

✓ **Réponse : B. Moteur (muscles, nerfs), sensoriel (fusion) et accommodatif**

La physiopathologie générale du strabisme repose sur un déséquilibre entre trois systèmes : moteur (muscles, nerfs), sensoriel (fusion) et accommodatif. Un strabisme apparaît lorsque ces systèmes ne sont plus synchronisés.

Question 40 - Quel est le rôle principal de l'orthoptiste dans la prise en charge du strabisme concomitant ?

✓ **Réponse : C. Intervenir à toutes les étapes (dépistage, bilan, rééducation, suivi) pour mesurer la déviation, évaluer les fonctions sensorielles et améliorer la vision binoculaire**

L'orthoptiste joue un rôle central à toutes les étapes de la prise en charge : dépistage, bilan orthoptique, rééducation (traitement de l'amblyopie, amélioration de la fusion) et suivi. Son expertise est essentielle pour mesurer précisément la déviation et évaluer les fonctions sensorielles.